Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

4ª Vara da Fazenda Pública do DF

Fórum Desembargador Joaquim de Sousa Neto (Fórum VERDE)

SAM Norte, Lote M, Bloco 1, Sala 207, 2º andar, Brasília/DF

Cartório Judicial Único - 1ª a 4ª Vara da Fazenda Pública

Telefone: (61) 3103-4321 // Email: cju.faz1a4@tjdft.jus.br

Processo: 0718200-68.2025.8.07.0001

Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: IRAN DE ANDRADE

REU: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por IRAN DE ANDRADE contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, ambos qualificados nos autos.

Alegou o autor que foi diagnosticado com neoplasia maligna do rim, tendo a biópsia identificado carcionoma de células renais do tipo celular claras, motivo pelo qual foi determinado o início imediato do tratamento com seis ciclos dos medicamentos Keytruda (pembrolizumabe) e Inlyta (axitinibe), considerados indispensáveis para a contenção da doença e preservação de sua vida. Afirmou que a parte ré indeferiu o fornecimento dos medicamentos, ao argumento de que não constam na Diretriz de Utilização (DUT) da ANS. Requereu, liminarmente, que a parte ré disponibilize os medicamentos, pelo período previsto em seus ciclos, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser quantificado por este Juízo (id 232112341 a 232115508).

Foi deferido o pedido de tutela de urgência (id 232271689).

Emenda para a quantificação dos danos morais em R$10.000,00 (id 232611948).

A parte ré apresentou contestação ao id 236234646 e alegou que os medicamentos solicitados não possuem indicação para o caso do autor, encontrando-se fora da cobertura do plano de saúde. Discorreu sobre sua natureza jurídica e defendeu ser inaplicável o regramento previsto no Código de Defesa do Consumidor. Impugnou o pedido de indenização por danos morais. Em caso de condenação, requereu seja determinação a coparticipação do autor no custeamento do tratamento.

Réplica (id 239698220).

Determinado o retorno dos autos para sentença (id 240245814).

É o breve relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

No caso em apreço, vislumbro prescindível a produção de outras provas, tendo em conta que os argumentos e documentos carreados pelas partes são suficientes para dirimir o conflito, conforme disposições expostas no artigo 355, I, do CPC.

Não há preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas por este juízo. Estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como verifico a legitimidade das partes e o interesse de agir.

É incontroverso que a parte requerente é beneficiária do Plano de Assistência Suplementar à Saúde – GDF-SAÚDE, mantido e organizado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, o que também é demonstrado por meio da carteira do plano acostada ao ID 232115497.

Primeiramente, necessário se faz ponderar que quanto à aplicação do CDC ao caso *sub examine*, vige o teor da Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*". Como se sabe, o plano de saúde em questão é de autogestão, administrado pela Autarquia ré em benefício de seus membros e servidores. Assim, descabe a aplicação do referido diploma legal ao caso concreto.

Para a hipótese, o regimento interno do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS indica, em seu artigo 4º, que o instituto tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF.

Por sua vez, o Decreto n. 27.231, de 11 de setembro de 2006, aprovou o regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF SAÚDE-DF e estabeleceu expressamente, em seus Artigos 17 e 18, cobertura a serviços de apoio

diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais e hospitalares solicitados por médico assistente.

Conforme entendimento já consagrado pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. - TJDFT, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la.

Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico.

Faz parte das atribuições do profissional médico identificar o mal que aflige o cidadão que se coloca aos seus cuidados e, por conseguinte, definir os parâmetros e meios terapêuticos necessários para debelá-lo. Não se pode admitir que a entidade pública, por mais conscienciosa que se proponha a ser, seja capaz de albergar em um rol todas as medidas terapêuticas viáveis.

Indicando o profissional médico a necessidade do medicamento para a correção de doença diagnosticada, não pode se valer a operadora da tese que tal procedimento não é previsto no rol de cobertura obrigatória.

Nesse sentido, é o posicionamento do e. TJDFT:

> Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Plano de Saúde. Cobertura de Procedimento Cirúrgico bucomaxilofacial. Danos Morais. Cabimento. Honorários Advocatícios. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.
> I. Caso em exame
> 1. Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte para condenar que parte ré autorize o custeio do procedimento cirúrgico e ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A ré apela contestando o valor atribuído à causa, afirma que o tratamento solicitado não está coberto pelo regulamento do plano de saúde do INAS e requer seja excluída a condenação aos danos morais, vez que a recusa do tratamento não configuraria ato ilícito. A autora apela requerendo a majoração da condenação a título de danos morais e condenação da ré em honorários advocatícios tendo por base o valor dos danos morais somado ao valor da obrigação de fazer, qual seja a cirurgia bucomaxilofacial.
> II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se o valor atribuído à causa está correto; (ii) saber se o tratamento solicitado deve ser coberto pelo plano de saúde; (iii) saber se a condenação por danos morais é devida e seu quantum; (iv) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. Razões de decidir

3. O valor atribuído à causa está correto, conforme art. 292 do CPC, pois corresponde à soma do pedido de reparação por danos morais e do valor aproximado da cirurgia.

4. Mostra-se irrelevante o tratamento solicitado não estar coberto pelo regulamento do plano de saúde do INAS, vez que os planos de saúde em regime de autogestão devem seguir os regulamentos e à fiscalização da ANS, nos termos da Lei Federal n. 9.656/98. Estando o procedimento cirúrgico bucomaxilofacial (por meio de reconstrução óssea da maxila atrófica) abrangido pelo Rol da ANS, não há o que se falar em licitude da recusa de cobertura.

5. Conquanto se trate de descumprimento contratual, considera-se que sejam devidos danos morais diante de recusa injusta de plano de saúde em momento de grande fragilidade da pessoa, doente, em tratamento ou necessitando de acompanhamento médico, daí que se admite uma fixação módica que compense de alguma forma o sofrimento e sirva também como desestímulo a práticas semelhantes.

6. Assim sendo, é necessária a readequação da sucumbência, de maneira que a verba honorária deve ser fixada sobre a importância correspondente ao valor dos danos morais (R$5.000,00) e o valor do procedimento recusado, este a ser apurado em liquidação de sentença, visto que não há como indicar o valor certo da cobertura a que foi condenada a Ré. Precedente AgInt no REsp n. 2.054.713/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/5/2023, DJe 1/6/2023.

IV. Dispositivo

7. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 292 do CPC; Lei Federal n. 9.656/98.

(Acórdão 1980474, 0704867-66.2023.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.)

Ademais, irrelevante a discussão se os medicamentos indicados constam no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, pois a Lei n. 14.454/2022 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, constituindo apenas "*referência básica para os planos privados de assistência à saúde*".

De toda sorte, no caso em tela, o Anexo II da Resolução Normativa 64 prevê como obrigatório o fornecimento dos medicamentos solicitados pelo autor.

Portanto, não restam dúvidas quanto à responsabilidade do réu em fornecer o tratamento conforme a prescrição médica acostada aos autos.

Lado outro, frente à indispensabilidade de resguardo do equilíbrio-financeiro atuarial do plano autogestão, consigna-se que à autora também podem ser impostas obrigações, como é o caso do pagamento de quota de coparticipação, na forma do regulamento do INAS (Decreto n. 27.231/2006):

> Art. 25. O custeio do GDF-SAÚDE-DF far-se-á mediante: I contribuições dos beneficiários, inclusive coparticipação; II – contribuições suplementares, complementares ou extraordinárias autorizadas em Lei; III – contribuição mensal do Governo do Distrito Federal; IV – doação, legados, subvenções e outras rendas eventuais; V – reversão de qualquer importância; VI – juros, multas e correção monetária de pagamento de quantias devidas ao Instituto; e VII – rendas resultantes de aplicações financeiras, inclusive dos fundos de reserva. .... Art. 29. O beneficiário pagará coparticipações diferenciadas, pela utilização do mesmo evento nos diferentes níveis de rede credenciada. ANEXO V 1. Nos atendimentos ambulatoriais, a coparticipação corresponderá aos seguintes percentuais: 1.1 Assistência médica: a) 30% (trinta por cento) para atendimento ambulatorial em geral; b) 5% (cinco por cento) para atendimento ambulatorial de quimioterapia, radioterapia e terapia renal substitutiva"; PORTARIA Nº 07, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020... Art. 3º Para fins de manutenção do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do GDFSAÚDE-DF, as regras de coparticipação previstas no Anexo V do Regulamento do GDF-SAÚDE-DF ficam acrescidas das seguintes previsões: I - A coparticipação descrita neste artigo será limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por ano civil. II - O pagamento da coparticipação será descontado em folha, em parcelas não inferiores à R$ 200,00 (duzentos reais) e não superiores à 10% (dez por cento) da remuneração bruta do servidor, até quitação integral do débito.

Sobre esse ponto, o e. TJDFT entende que deve ser mantida cobrança de quota de coparticipação, nos casos em que o postulante obtém em Juízo resposta favorável à obtenção do tratamento. Veja-se:

> DIREITOS CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS. PLANO DE SAÚDE. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608 STJ. AUTOGESTÃO.

NORMAS DA ANS. SUJEIÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. mérito. (1) CâNCER DE MAMA. MEDICAMENTO. IBRANCE 125 MG. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. QUIMIOTERAPIA. REGULAMENTO DO PLANO. PREVISÃO. (2) PRESTAÇÃO CONTINUADA. RELATÓRIO DO MÉDICO ASSISTENTE. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. (3) COPARTICIPAÇÃO. REGULAMENTO DO PLANO. PREVISÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO, FINANCEIRO E ATUARIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DE OFÍCIO. DANOS MORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, conforme o teor da Súmula 608 do STJ. 2. Não se pode excluir os planos de saúde na modalidade de autogestão da sujeição ao poder regulamentar da ANS, pois se trata de assistência suplementar à saúde, nos termos do art. 1º, caput, da Lei n. 9.961/2000. 3. Não se constata inovação recursal quando o apelante apresenta em suas razões recursais questão jurídica que requereu a análise em petição inicial ou contestação, na forma de pedido alternativo, em razão da incidência do efeito devolutivo em profundidade, nos termos dos arts. 1.009, § 1º, e 1.013, caput e §§ 1º, 2º e 3º, III, ambos do CPC. Preliminar rejeitada. 4. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS - está constituído "sob a forma de Autarquia em Regime Especial, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa [do Distrito Federal, tendo] por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF", conforme emerge dos arts. 1º, caput, e 2º, ambos da Lei Distrital n. 3.831/2006. 5. Este plano "consiste na cobertura das despesas decorrentes de atendimentos médicos, ambulatoriais, hospitalares, fisioterapêuticos, fonoaudiológicos e psicológicos, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, prestados aos beneficiários do Plano, na forma que vier a ser estabelecida em regulamento", nos termos do art. 13, caput, desta Lei Distrital. 6. O Apelante tem obrigatoriedade de fornecer à Apelada o medicamento Ibrance 125mg, nos termos da prescrição do médico assistente e enquanto durar o tratamento correlato, pois se trata de fármaco não excluído do rol do Anexo IV do Regulamento do Plano de Saúde GDF-SAÚDE-DF, aprovado pelo art. 1º do Decreto Distrital n. 27.231/2006, em razão da quimioterapia sistêmica, no âmbito ambulatorial, ser coberta pelo Rol do Anexo da Resolução ANS n. 82/2004, e da substância Palbociclibe,

a qual integra este fármaco (registrado na ANVISA), conforme emerge da bula profissional, possuir indicação da ANS para o tratamento da patologia de que é diagnosticada a Apelada, consoante a DUT 64 da Resolução ANS n. 465/2021. 7. Em se tratando de prestação continuada, como o fornecimento de medicamento enquanto durar o tratamento correlato, é necessária a renovação periódica do relatório do médico assistente, enquanto medida para resultar na prestação da tutela pelo resultado prático equivalente ao adimplemento, nos termos do art. 139, IV, do CPC. 7.1. Assim, não ensejará a perda de eficácia da medida, acaso sobrevenha tecnologia mais avançada do que o fármaco requerido, consoante o Enunciado n. 02 da III Jornada de Direito de Saúde, do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, criado pelo CNJ em idos de 2010. **8. O Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF, possui a coparticipação como diretriz de seu "financiamento pelos seus beneficiários" - servidores ativos e inativos do Distrito Federal e seus dependentes - e fonte de receita e de custeio, nos termos dos arts. 4º, IV, e 20, I, ambos da Lei Distrital n. 3.831/2006, c/c, art. 25, I, do Regulamento deste Plano de Saúde, aprovado pelo art. 1º do Decreto Distrital n. 27.231/2006. 8.1. Para a "assistência médica, nos atendimentos ambulatoriais, a coparticipação corresponderá [ao percentual de] 5% (cinco por cento) para atendimento ambulatorial de quimioterapia; [bem como] para todos os atendimentos realizados em regime de internação clínica e cirúrgica, inclusive com utilização de OPMEs; limitada a R$ 5.000,00 por evento, valor este que será corrigido anualmente, de acordo com Ato Normativo do INAS", consoante os itens 1.1, "b" e 2, ambos do Anexo V, deste Regulamento.** 9. Atualmente, o limite de coparticipação passou a ser de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por ano civil e "o pagamento da coparticipação será descontado em folha, em parcelas não inferiores à R$ 200,00 (duzentos reais) e não superiores à 10% (dez por cento) da remuneração bruta do servidor, até quitação integral do débito", consoante o art. 3º, I e II, da Portaria INAS n. 07, de 21 de dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 24/12/2020. 10. Sobrevindo a sucumbência recíproca, cabe à parte processual interessada a interposição de apelação principal ou recurso adesivo, nos termos do art. 997, caput e § 1º, do CPC, pois a peça de contrarrazões é de resistência à pretensão recursal, não sendo cabível para impugnação de sentença (CPC, Art. 1.009, caput). 10.1. Eventual pedido contraposto, apresentado em contrarrazões, não deve ser conhecido, pois estará configurada a ausência de interesse recursal, em razão da inadequação da via eleita, de acordo com o art. 17 deste Código, pois esta peça está sendo usada em substituição do recurso cabível. 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte,

para determinar a necessidade de atualização do relatório do médico assistente e da cobrança da coparticipação. Valor das astreintes reduzido de ofício. Pedido contraposto apresentado em contrarrazões. Não conhecido". (Acórdão 1675329, 07108715620228070018 (https://pje-interno.tjdft.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/204656444), Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso

É importante notar que o dano extrapatrimonial ocorre quando há violação de um dos direitos da personalidade de um indivíduo, os quais abrangem a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, entre outros, conforme dispõe o Art. 5º, Incisos V e X, da Constituição Federal.

Para a configuração do dano moral, é essencial que o prejuízo ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento cotidiano que justifica a indenização por danos extrapatrimoniais. Portanto, todos os fatos e circunstâncias do caso devem ser analisados para verificar a ocorrência, ou não, de lesão aos direitos de personalidade que possam justificar reparação.

No caso em tela, o aviltamento se agrava ao se descobrir que anos de assiduidade com o cumprimento de suas obrigações foram, simplesmente, em vão. Afinal, qualquer cidadão em sã consciência presume que, nestes momentos prementes, terá o resguardo da pessoa jurídica com quem possui um contrato de plano de saúde. Pensa que lhe será proporcionado tratamento condigno que, se não lhe propicia cura, lhe garante uma melhor qualidade de vida, de modo que a não oferta do tratamento nos exatos termos da prescrição médica enseja o reconhecimento de danos morais.

Nesse sentido:

CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORMA REMITENTE RECORRENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS. ART. 85, § 2º, CPC/2015. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em regra o descumprimento contratual não é capaz de produzir ofensa moral. Porém, como reiteradamente decidido pela Corte e em face da orientação do STJ, os casos de negativa de cobertura de tratamento de saúde, estes, sim, provocam grande sofrimento e aflição nos contratantes pelo fato de se verem obrigados a suportar o incômodo de saúde. 2. Quanto ao valor da compensação por danos morais, a sua fixação deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano. A indenização não pode, contudo, ser tão grande que se torne fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem tão pequena que se torne inexpressiva, a ponto de não atingir o seu caráter compensatório e punitivo. Atento a essas diretrizes, revela-se razoável a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais por recusa de tratamento pelo plano de saúde. 3. Em relação à verba honorária, o entendimento do Superior Tribunal de

> Justiça é no sentido de que deve ser incluída na base de cálculo a condenação em obrigação de fazer, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (Acórdão 1891907 (https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj?visaoId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentaca 07269806520238070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

É cediço que quem causa dano a outrem tem o dever de repará-lo, frisando que a indenização por lesão extrapatrimonial obraria apenas como medida consolatória para a vítima, apresentando caráter compensatório, pois o mal irremediável, suportado pelo lesado, nunca poderá ser reparado por nenhum valor pecuniário.

Para quantificar a indenização fundada em danos morais, mostra-se necessário sempre atentar para o fato de que não se deve, com a condenação, gerar outra iniquidade além daquela que lhe deu azo, nem, tampouco, enriquecer a vítima com o episódio, uma vez que o escopo dessa reparação não é lhe conceder um plus, mas um ressarcimento de natureza moral.

Também não se pode permitir que a gravidade do episódio, vista de acordo com cada caso, seja subestimada, aplicando-se uma condenação ínfima a ponto de não se prestar a punir a conduta do ofensor.

Analisando as circunstâncias do caso presente, entendo razoável a título de indenização por dano moral a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), suficiente a reparar, na espécie, o mal sofrido.

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, confirmo a liminar de id 232271689, e **JULGO PROCEDENTE** os pedidos iniciais, o que faço para condenar a parte ré *i)* na obrigação de fazer consistente no fornecimento dos medicamentos pembrolizumabe e axitinibe, conforme prescrito em relatório médico ID 232115500 (https://pje-interno.tjdft.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/TJDFT/1g/4289236/232115500), observadas as condições de custeio estabelecidas no regulamento do GDF SAÚDE-DF; *ii)* ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com atualização pela SELIC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Resolvo o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

O réu é isento de custas.

Ante a sucumbência, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios devidos ao procurador da parte contrária, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º e §3º, do CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária (artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil).

Transitada em julgado, feitas as comunicações de estilo, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.

BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2025

ALANNA DO CARMO SANKIO

Juíza de Direito Substituta

Assinado eletronicamente por: ALANNA DO CARMO SANKIO
17/07/2025 13:49:12
https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25071713491184600000220

IMPRIMIR GERAR PDF